Ospedale Santa Maria della Rocca
Dipartimento dei Servizi Diagnostici
S.S.D. Farmacogenetica e Genetica Molecolare

Piazzale Monteluce Alta 9 - 06129 Perugia
Segreteria 075 5783340
farmacogenetica@smrocca.example.it

REFERTO DI FARMACOGENETICA

Genotipizzazione del gene DPYD prima di terapia con fluoropirimidine

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Franca Ceccarelli**	Codice fiscale:	**CCCFNC57H48G478K**
Data di nascita:	**08/06/1957**	N. ricetta (NRE):	**1000A4127763309**
U.O. richiedente:	**S.C. Oncologia Medica**	N. referto:	**FG-24-2215**
Data accettazione:	**07/10/2024**	Data referto:	**10/10/2024**

Indicazione: valutazione del rischio di tossicità prima dell'avvio di capecitabina in paziente con adenocarcinoma del colon pT3N1a operato.

Metodo: PCR real-time con sonde allele-specifiche su DNA da sangue periferico. Varianti analizzate secondo le raccomandazioni CPIC ed EMA.

Gene	Variante (HGVS c.)	Nome comune	Genotipo	Activity score
DPYD	c.1905+1G>A	DPYD*2A	Wild type	1
DPYD	c.1679T>G	DPYD*13	Wild type	1
DPYD	c.2846A>T	p.(Asp949Val)	Eterozigote A/T	0,5
DPYD	c.1129-5923C>G	HapB3	Wild type	1

INTERPRETAZIONE

Genotipo compatibile con metabolizzatore intermedio DPYD (activity score complessivo 1,5). Secondo le raccomandazioni vigenti si suggerisce di iniziare la terapia con una riduzione della dose iniziale di fluoropirimidina del 50%, con successiva titolazione in base alla tollerabilità clinica.

> *L'assenza delle varianti analizzate non esclude del tutto il rischio di tossicità severa, che può dipendere da varianti rare non incluse nel pannello o da fattori non genetici.*

Il Dirigente Biologo responsabile
Dott.ssa Sabrina Mencarelli

Perugia, 10/10/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.